随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

六、鉴别诊断

	缺铁贫	慢性病贫血*	铁粒幼贫血（铁利用障碍） 铁粒幼和地贫与缺铁贫对比记忆	珠蛋白生成障碍性贫血
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓	吃↓	↑	↑
血清铁蛋白（储存铁）	↓	存↑	不缺铁（只是不能用）↑	↑
反应饥渴 总铁结合力	↑	吃↓	所以不饥渴　正常（不低）	正常或↓
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓	吃↓	铁利用障碍，堆在幼红细胞↑ 环形排列（环形铁粒幼红细胞＞15%）	↑
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓	存↑	↑	↑

*慢性病贫血（结核、肿瘤等炎症性贫血）：≠慢性失血

①慢性消耗性疾病→巨噬细胞亢进→吞噬了过多的含铁物质、将其转化为储存铁（铁蛋白和含铁血黄素）

ttsx 吃吃吃、存存存

是肠道吸收铁、巨噬细胞释放铁的主要负调控因子

②慢性炎症→铁调素↑→小肠铁吸收↓、铁从巨噬细胞释放↓ 牢牢存在巨噬细胞里

③慢性炎症→肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β↑→抑制早期红系祖细胞增殖（治疗用 EPO）肿么敢生

抑制晚期红系祖细胞凋亡

不能用也不能贮存铁了

转铁蛋白缺乏症：血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、骨髓含铁血黄素↓

转铁蛋白饱和度TS=血清铁÷总铁结合力

专题串联·贫血概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）贫血的诊断

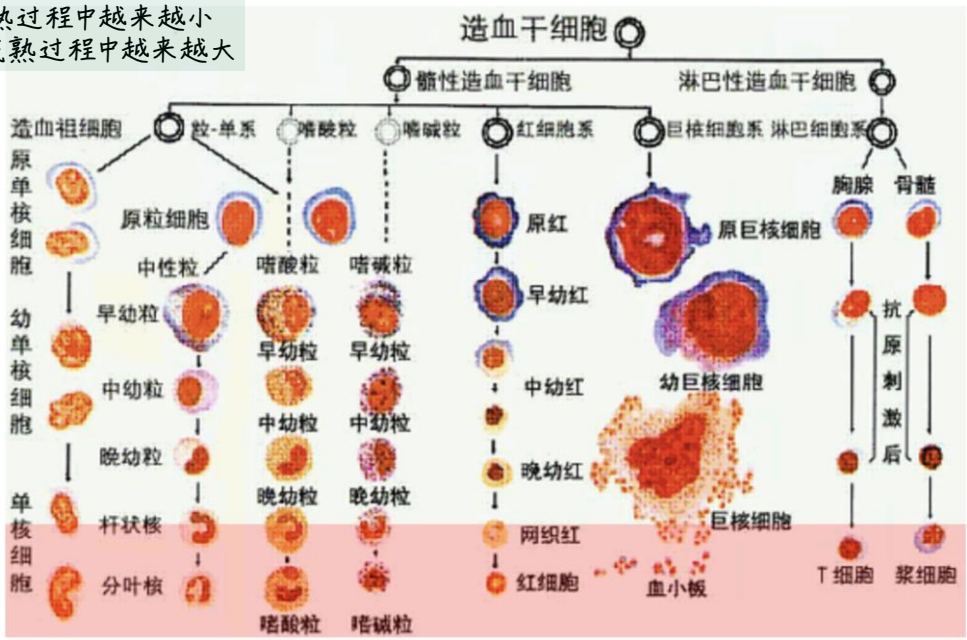
雌激素影响EPO　血容量↑

男 Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100（男人打架 120）

轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

规律：血细胞成熟过程中越来越小

特殊：巨核细胞成熟过程中越来越大



在外周血中看到细胞核：红白血病（早幼红）、骨髓红系代偿（eg.失血溶血，多见中/晚幼红）

EPO机制：

①抑制晚期红系祖细胞凋亡（主要）现在延迟退休　老头不准死

②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成

③促进网织红细胞成熟与释放